

ディスポーザブル把持鉗子 LA LA-201、LA-202



1 図記号の説明



取扱説明書参照



再使用禁止



使用期限



エチレンオキシドガス滅菌済



ロット番号



滅菌ロット番号



日光禁止



湿気厳禁



再滅菌禁止



包装破損した滅菌品使用禁止



この製品は天然ゴム（ラテックス）
を使用していない。

2 使用目的

本製品は内視鏡的処置を補助するために、当社指定の内視鏡に装着して視野を確保し、胃内の組織の把持、けん引に使用することを目的としています。この目的以外には使用しないでください。

3 取扱説明書について

本取扱説明書には、本製品を安全かつ効果的に使用するうえで必要不可欠な情報が盛り込まれています。使用に先立ち、必ず本取扱説明書および同時に使用する機器の『添付文書または電子化された添付文書』や『取扱説明書』を熟読し、その内容を十分に理解し、その指示に従って使用してください。本取扱説明書および関連するすべての文書は、すぐに読める場所に保管してください。本取扱説明書の内容について不明な点がある場合は、内視鏡お客様相談センター、当社指定のサービスセンターまたは当社支店、営業所にお問い合わせください。

4 使用者の資格について

本製品は、医師または医師の監督下の医療従事者が使用するものであり、内視鏡の臨床手技については使用者の側で十分な研修を受けて使用することを前提としています。したがって、本取扱説明書では内視鏡の臨床手技に関する事項には触れていません。内視鏡の臨床手技の詳細はそれぞれの専門の立場から判断してください。

5 警告表示

警告

それを守らないと死亡、または重傷につながる可能性のある事柄を示しています。

注意

それを守らないと中程度以下の傷害、または機器の破損につながる可能性のある事柄を示しています。

参考

使用にあたっての有効な知識、情報などの内容を示しています。

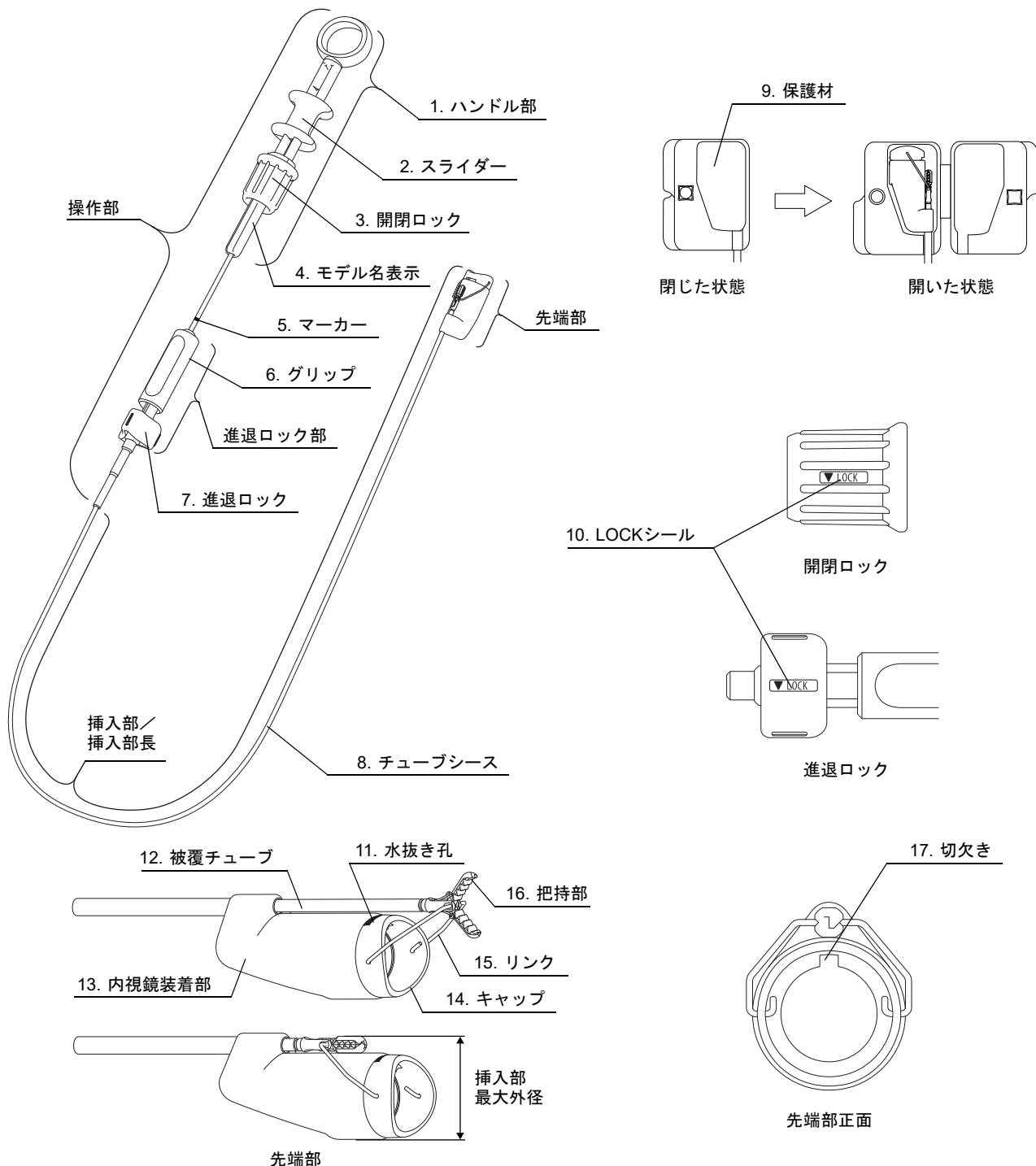
6 取り扱い上および一般的な注意事項について

本製品を取り扱う際は、以下の注意事項を厳守してください。また、各章にもおのこの注意事項が記載されていますので、併せて注意してください。

警告

- ・ 内視鏡的に対応できない事態の発生に備えて、外科手術への移行態勢および入院計画を整えたうえで使用してください。
- ・ 本製品は以下の条件を満たした場合に限り使用していただくことを前提としていますが、場合によっては本製品の使用により、外科的手術、穿孔、大出血などにつながるおそれがあります。本製品の使用の際にはその可能性を十分に理解したうえで、使用してください。
 - － 本製品は医師または医師の監督下の医療従事者に使用されるものであり、使用者が臨床例紹介ビデオを参照して、臨床手技に対する理解を十分に深めたうえで使用してください。
 - － 本製品は緊急処置として外科的手術などが可能な場合に限り使用してください。
- ・ 絶対に分解および改造をしないでください。また本製品は修理できない構造になっています。分解、改造または修理をすると人体への傷害、機器の破損につながるおそれがあり、また機能の確保ができません。

7 各部の名称と機能



1. **ハンドル部**
進退ロック部に対して押し引きすることで把持部を進退します。
2. **スライダー**
手前に引くと把持部が閉じ、押すと把持部が開きます。
3. **開閉ロック**
スライダーに突き当て、ハンドル部に対してLOCKシールの矢印の向きに回転させて締め付けることで、把持部の開閉を制限できます。
4. **モデル名表示**
モデル名が表示されています。
5. **マーカー**
マーカーが完全に見えていることで把持部が手元側に引き込まれ、内視鏡装着部に沿っていることを示します。
6. **グリップ**
進退ロックを回転するときに保持します。グリップの内側には、把持部の進退を制限するためのゴムリングが収納されています。
7. **進退ロック**
グリップを保持した状態で、LOCKシールの矢印の向きに回転させて締め付けることで、把持部の進退を制限できます。
8. **チューブシース**
被覆チューブの進退のガイドとして働きます。
9. **保護材**
先端部を収納し、保護しています。本製品の点検の前には取りはずします。
10. **LOCKシール**
開閉ロックおよび進退ロックをロックするときの回転方向を示します。
11. **水抜き孔**
水抜き孔を通じて内視鏡視野から液体が排出されます。
12. **被覆チューブ**
高周波電流を絶縁します。
13. **内視鏡装着部**
内視鏡先端部への装着部分として働きます。
14. **キャップ**
視野を確保するスペースとして働きます。
15. **リンク**
キャップと把持部の接続部として働きます。
16. **把持部**
組織を把持します。
17. **切欠き**
本製品を内視鏡先端に装着する際、内視鏡画像上で把持部が突出する位置を示します。

8 仕様

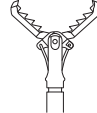
警告

本製品は以下に示す関連製品との組み合わせで使用してください。以下の組み合わせ以外で使用した場合、人体への傷害、機器の破損につながるおそれがあり、また機能の確保ができません。

8.1 使用環境

周囲温度10～40℃、相対湿度30～85%、気圧700～1060hPa

8.2 仕様

モデル名	LA-201	LA-202
把持部の形状	N字鰐口型 	把持部正面図 (閉じた状態) 
挿入部最大外径 (mm)	φ13.85	φ14.95
挿入部長 (mm)	1950	
把持部開き幅 (mm)	8	
組み合わせ可能な 当社内視鏡	GIF-V70/XQ230/XQ240/SP240/XQ260/Q260	GIF-V/Q240/Q240X/H260/Q260J
組み合わせ可能な 当社マウスピース	MB-142、MAJ-674	
組み合わせ可能な オーバーチューブ	住友ベークライト株式会社製フレキシブルオーバーチューブ MD-48518、MD-48618	

9 保管

警告

滅菌パックに破れ、シール部のはがれ、水などによるぬれが発生するおそれのある場所に保管しないでください。滅菌パック内の無菌状態を保てず、感染、組織の炎症などにつながるおそれがあります。

水ぬれに注意し、常温、常湿で、かつ直射日光の当たらない清潔な場所に保管します。

10 使用法

警告

- 本製品を使用中に異常が疑われた場合は使用を中止してください。また、対処方法が不明な場合はオリンパスに問い合わせてください。
- 本製品は胃内での処置を前提としています。それ以外の部位では使用しないでください。穿孔、大出血、粘膜損傷や機器の破損などにつながるおそれがあります。
- 滅菌パックに記載されている使用期限の過ぎた本製品は使用しないでください。感染、組織の炎症などにつながるおそれがあります。
- 使用時および点検時には、適切な保護具を常に着用してください。保護具を着用しないと、本製品に付着した患者の血液や粘液などにより感染や皮膚の炎症などにつながるおそれがあります。保護具としては、ゴーグル、フェイスマスク、防水性保護服、耐薬品性および絶縁性のある防水性手袋などがあります。
- 使用前に必ず以下に示す準備と点検をしてください。なんらかの異常が疑われる場合は使用しないで、予備の本製品を使用してください。異常が疑われる本製品を使用すると、正常に機能しないだけでなく、感染、組織の炎症、穿孔、大出血、粘膜損傷、組織の熱傷、患者のやけどなどにつながるおそれや機器の破損または機能の低下につながるおそれがあります。

注意

- 本製品に過度な曲げや引っ張りや圧迫を加えないでください。機器の破損または機能低下につながるおそれがあります。
- 挿入部を直径15cmより小さく丸めないでください。挿入部が破損するおそれがあります。
- 先端部を保護材に入れた状態で把持部の進退、開閉を行わないでください。先端部が破損するおそれがあります。
- 点検または手技中に、本製品を体腔外で一時放置する場合は、把持部を閉じ、内視鏡装着部に沿った状態に維持してください。把持部を開いたり、把持部を内視鏡装着部から離れた状態で放置すると、本製品の破損につながるおそれがあります。

参考

本製品は製造時の滅菌性を確保するため、グリップと進退ロックをはずした状態で滅菌パックに封入されています。点検および使用の際は、グリップと進退ロックを組み付けたうえで使用してください。また、グリップと進退ロックが軽く組み付いた状態で滅菌パックに封入されている場合もありますが、滅菌性は確保されています。

10.1 使用前に準備するもの

予備の本製品

不測の故障に備えて、予備の本製品を準備します。

医療用テープ

本製品を内視鏡先端部に固定するために、清潔で伸縮性のある医療用テープを準備します。

生理食塩水

内視鏡先端部への装着に使用するために準備します。

潤滑剤

体腔内およびオーバーチューブ内への挿入をスムーズにするために準備します。

清潔なガーゼ

使用した潤滑剤、生理食塩水をふき取るために、清潔なガーゼを準備します。

異物回収用把持鉗子

医療用テープが脱落したときのために準備します。

清潔な綿棒

内視鏡先端の汚れを取るために清潔な綿棒を準備します。

10.2 本製品の点検

保護具をその『添付文書または電子化された添付文書』や『取扱説明書』に従って身に着けます。

滅菌パックの点検

警告

本製品は再滅菌しないでください。感染および本製品の破損などにつながるおそれがあり、また機能の確保ができません。

滅菌パックに破れ、シール部のはがれ、水などによるぬれなどの異常がないことを確認します。滅菌パックに異常が見つかった場合には、無菌状態が保たれていないため、使用しないでください。

組み立て

進退ロックにグリップを軽く押し付けた状態で、グリップを時計回りに回転させ、進退ロック部を軽く組み付けます（図1参照）。

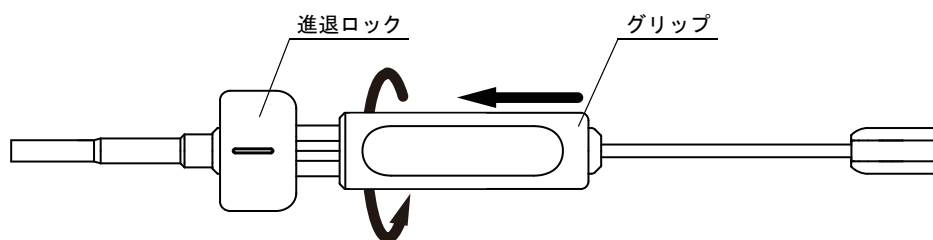


図1

外観の点検

1. 本製品から保護材を取りはずします。
2. 接続部にはずれ、緩みがないことを確認します。
3. 「7 各部の名称と機能」の図を参照して、先端部に著しい変形、鋭利な部分がないことを確認します。
4. ハンドル部、進退ロック部にヒビ、欠け、著しい変形がないことを確認します。
5. 内視鏡装着部ならびにキャップにキズ、ヒビ、欠け、破れ、変形がないことを確認します。
6. チューブシースを軽く指でつまみ、全長にわたって滑らせて、つぶれ、著しい折れ曲がり、チューブシースの破れがないことを確認します。

作動の点検

1. グリップに対して、ハンドル部を前後に動かし、スムーズに把持部が進退することを確認します。なお、把持部の進退が重い場合は、グリップと進退ロックの締め付けを緩めてください。
2. 把持部を前方に突出した状態で、挿入部先端に直径約20cmの一重ループを作ります（図2参照）。

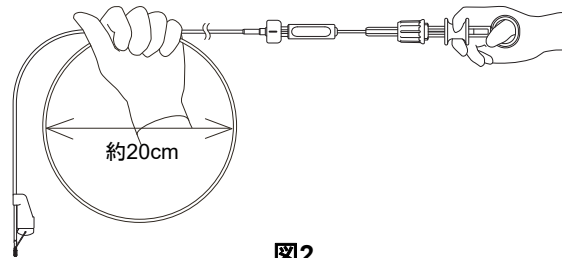


図2

3. スライダーを前後に動かし、スムーズかつ確実に把持部が開閉できることを確認します。

ロック部の作動点検

1. 開閉ロックがスムーズに前後へ動くことを確認します。
2. スライダーを引き、開閉ロックをスライダーに突き当て、開閉ロックをLOCKシールの矢印の向きに回転させます。開閉ロックがスムーズに回転し、ロック後にスライダーを押しても前へ動かないことを確認します（図3参照）。

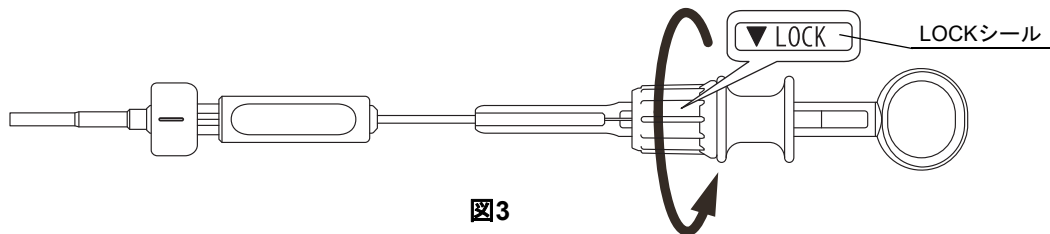


図3

3. グリップを保持し、進退ロックをLOCKシールの矢印の向きに回転させます。進退ロックがスムーズに回転し、ロック後に進退ロック部に対してハンドル部を軽く押しても動かないことを確認します（図4参照）。

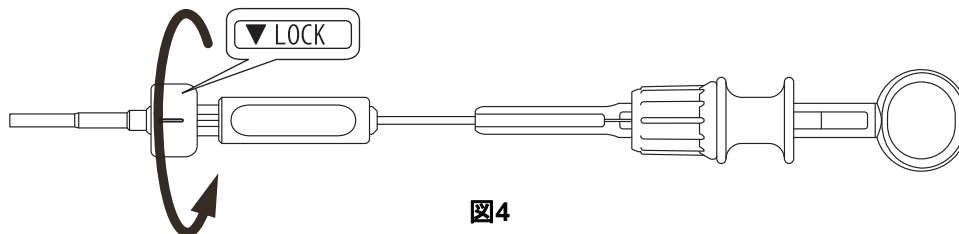


図4

4. 各ロックを解除します。

10.3 本製品の使用方法

警告

- ・ 高周波処置具と併用する際は、高周波処置具先端部をキャップ内に引き込んで通電しないでください。引き込んで通電を行うと、キャップ内のリンクと高周波処置具先端部が接触することで、穿孔、出血、粘膜損傷のおそれがあります。
- ・ 体腔内で本製品の内視鏡からのはずれ、作動不良、破損が疑われた場合は、無理な操作および引き抜きをせず、外科手術などの可能な処置を行ってください。無理な操作および引き抜きをすると、穿孔、出血、粘膜損傷などにつながるおそれや、本製品の破損につながるおそれがあります。
- ・ 把持部の進退操作は挿入前に把持部の動きを十分に理解したうえで行ってください。また抵抗が大きく、把持部の進退が困難な場合は、無理な力で把持部を進退させないでください。無理に進退させると、穿孔、大出血、粘膜損傷などにつながるおそれがあります。

内視鏡への装着、固定

警告

- ・ 本製品を装着する際は、内視鏡湾曲部に強い力がかからないようにできる限り内視鏡先端を保持してください。内視鏡湾曲部に強い力がかかると、内視鏡湾曲部の破損につながるおそれがあります。
- ・ 本製品を装着する際は、内視鏡先端部を清潔にし、内視鏡先端部および内視鏡装着部内面を生理食塩水でぬらし湿潤状態にしてください。湿潤状態で装着しないと本製品および内視鏡先端部の破損につながるおそれがあります。
- ・ 本製品を装着する際は、生理食塩水以外で内視鏡先端部および内視鏡装着部内面を湿潤状態としないでください。生理食塩水以外を使用すると、本製品の脱落による出血、粘膜損傷につながるおそれがあります。

警告

- ・ 内視鏡と内視鏡装着部を固定する医療用テープは8mmにカットしたものを使用してください。8mmを超えるテープを使用すると、テープの浮きによる出血、粘膜損傷およびテープのはがれによる本製品の脱落につながるおそれがあります。
- ・ 本製品を装着する際は、リンクおよび把持部を把持せず、キャップの側面を把持してください。リンクおよび把持部を把持すると、本製品の破損および術者がけがをするおそれがあります。
- ・ 粘液や血液、潤滑剤などが付着した内視鏡に本製品を装着する際は、内視鏡先端を十分にふき取った後、装着および医療用テープでの固定を行ってください。粘液や血液、潤滑剤などを十分にふき取らないと、内視鏡先端部への固定が確実にできず、使用中に内視鏡装着部がはずれ、出血、粘膜損傷につながるおそれがあります。
- ・ 医療用テープで内視鏡装着部およびチューブシースを固定する際は、装着時に使用した生理食塩水を清潔なガーゼで十分にふき取ってください。生理食塩水をふき取らずに医療用テープで固定すると、使用中に内視鏡装着部や医療用テープが内視鏡からはずれて、粘膜損傷、出血、組織の炎症につながるおそれがあります。
- ・ 医療用テープで内視鏡とチューブシースを固定する際は、内視鏡の湾曲部を避け、内視鏡先端から30cm以上離れた位置を医療用テープで固定してください。内視鏡の湾曲部を固定すると、内視鏡湾曲部の破損および医療用テープの浮きによる出血、粘膜損傷につながるおそれがあります。
- ・ 本製品を装着する際は、内視鏡先端部および内視鏡装着部にワセリン（ワセリンを含有する薬品）、オリーブオイル、アルコール、キシロカインスプレーを使用しないでください。本製品の破損、脱落による出血、粘膜損傷につながるおそれがあります。
- ・ 内視鏡装着部およびチューブシースは伸縮性のある医療用テープで確実に固定してください。伸縮性のない医療用テープを使用すると、内視鏡先端部への固定が確実にできず、使用中に内視鏡装着部がはずれて、出血、粘膜損傷につながるおそれがあります。
- ・ 医療用テープで固定する際は、医療用テープを内視鏡装着部に2～3周巻いて確実に固定してください。確実に固定しないと、使用中に内視鏡装着部がはずれて、出血、粘膜損傷を与えるおそれがあります。
- ・ 医療用テープで固定する際は、医療用テープを厚く巻きすぎないでください。医療用テープを厚く巻きすぎると、体腔内への挿入が困難になり、出血、粘膜損傷につながるおそれがあります。
- ・ 医療用テープによる固定後は、内視鏡湾曲機構の点検(方法は組み合わせる内視鏡の点検方法による)を行い、内視鏡の湾曲部がスムーズに湾曲することを確認してください。確認せずに使用すると、出血、粘膜損傷につながるおそれや、本製品の破損につながるおそれがあります。
- ・ 医療用テープで固定後に装着向きを変更する場合は、まず医療用テープをはずし、一度内視鏡から本製品を取りはずして再度付け直してください。無理に装着向きを変更すると、内視鏡および本製品の破損につながるおそれがあります。
- ・ 体腔内に本製品固定用の医療用テープが脱落した場合は、確実に回収してください。脱落により組織の炎症および粘膜損傷につながるおそれがあります。

注意

内視鏡と内視鏡装着部を医療用テープで固定する際は、把持部および被覆チューブ、リンクを医療用テープで固定しないでください。把持部および被覆チューブ、リンクを医療用テープで固定すると、把持部が進退できなくなります。

1. 内視鏡装着部を固定するため、医療用テープを幅8mmにカットします（図5参照）。なお、チューブシースを固定する医療用テープは、カットせずに使用することができます。

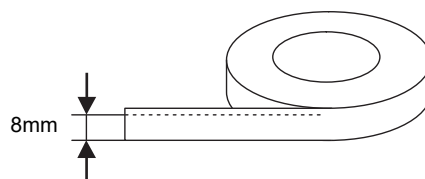
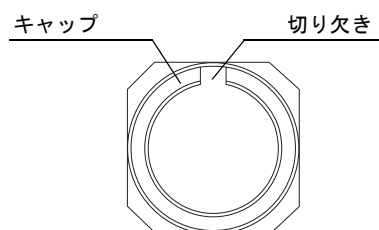


図5

2. 本製品を装着する際は、内視鏡先端部を清潔にし、内視鏡先端部および内視鏡装着部内面を生理食塩水でぬらし、湿潤状態にします。
3. 内視鏡画像を確認しながら、キャップ内面の切欠きの位置を参考に本製品の装着を行います（図6参照）。
4. 内視鏡先端がキャップに突き当たり、切欠きが見えなくなるまで確実に内視鏡装着部内へ押し込みます。



装着途中の内視鏡画像

図6

5. 装着時に使用した生理食塩水を清潔なガーゼで十分にふき取ります。
6. 本製品の内視鏡装着部を医療用テープ（幅：8mm）で、図7に示す貼り付け範囲からはみださないように、内視鏡先端部に固定します（図7参照）。
7. 内視鏡をまっすぐな状態にし、内視鏡先端から30cm以上離れた位置で、チューブシースを医療用テープで固定します（図7参照）。

医療用テープ貼り付け範囲：8mm

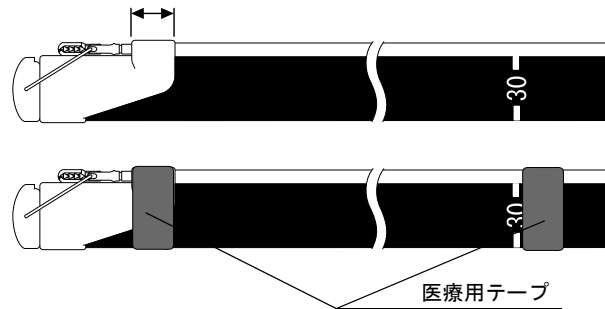


図7

8. 医療用テープによる固定後は、内視鏡湾曲機構の点検（方法は組み合わせる内視鏡の点検方法による）を行い、内視鏡の湾曲部がスムーズに湾曲することを確認します。
9. キャップを指でつまみ、軽く引っ張って内視鏡先端部からはずれないことを確認します。
10. 把持部が確実に進退することを確認します。
11. 把持部を元の位置に戻します（図7参照）。

体腔内への挿入

警告

- 本製品は挿入部の最大外径が大きだけでなく、径方向に突起や段差を有する形状のため、穿孔、出血、粘膜損傷などを生じさせる可能性が、本製品を装着していない内視鏡と比較すると高くなっています。そのため、本製品の患者への挿入にあたっては、本製品の形状および構造を十分に理解し、無理な挿入を避けてください。特に梨状陥凹、咽頭部、食道、噴門、幽門の通過については十分注意し、解剖学的、組織学的な観点で懸念される場合は、医師の判断によりオーバーチューブの使用や本製品の使用中止を決定してください。無理に挿入すると、穿孔、出血、粘膜損傷につながるおそれがあります。
- 体腔内もしくはオーバーチューブに挿入する前に、先端部およびマーカを確認し、把持部が確実に手元側に引き込まれ、内視鏡装着部に沿った状態であることを確認してください。また挿入中は、把持部が進退しないように操作部を保持するか、進退ロックを掛けてください。本製品が内視鏡に沿った状態でなかったり、把持部が進退してしまうと、穿孔、大出血、粘膜損傷などにつながるおそれがあります。
- 体腔内もしくはオーバーチューブへ挿入する前に、把持部が確実に閉じていることを確認してください。また挿入中は把持部が開閉しないようにスライダーを引き続けるか開閉ロックを掛けてください。把持部が開いた状態で挿入を行うと、穿孔、大出血、粘膜損傷などにつながるおそれや機器の破損につながるおそれがあります。
- 体腔内もしくはオーバーチューブへ挿入する際は、内視鏡挿入部および本製品の先端部外面、オーバーチューブの挿入口に潤滑剤を塗布してください。潤滑剤を塗布しないと、挿入時に粘膜損傷またはオーバーチューブ破損につながるおそれがあります。
- 本製品の各操作部（進退ロック部、ハンドル部）は、ロック状態でも把持部もしくは操作部に大きな力が負荷されると動く可能性があります。ロック中は、各操作部に不用意な力をかけないように操作部を保持してください。挿入時に把持部の開閉もしくは進退がおこると、穿孔、出血、粘膜損傷などにつながるおそれがあります。
- 体腔内への挿入が困難な場合は、無理に押し込まずに一度引き抜き、異常がないことを確認のうえ、医師の判断により再挿入もしくはオーバーチューブの使用、または本製品の使用中止してください。穿孔、出血、粘膜損傷につながるおそれがあります。
- 体腔内への挿入時における潰瘍底面への接触ならびにクリップとの接触には十分注意してください。無理に挿入すると、穿孔、大出血、粘膜損傷などにつながるおそれや、本製品の破損につながるおそれがあります。
- 1 症例に複数回挿入する場合は、引き抜くごとに、医療用テープの緩み、はずれ、各部の破損がないことを確認し異常を感じた場合は、使用中を中止してください。なんらかの異常があると、穿孔、出血、粘膜損傷などにつながるおそれがあります。
- 体腔内への挿入時は、キャップ内の粘液や血液などを吸引、掃除をし、十分な視野を確保してから挿入してください。視野が確保されていないと、穿孔、出血、粘膜損傷などにつながるおそれがあります。
- 本製品を装着した状態で内視鏡先端を掃除する際は、キャップ内に指を入れず、綿棒などで行ってください。指を入れると、キャップ内のリンクに指が触れ、けがおよび感染につながるおそれがあります。

参考

本製品は伸縮性のある材料で作られているため、マーカが見えるまでハンドル部を引き込んだ後に、引き込みを解除すると、マーカが進退ロック部内へ戻ってしまう場合があります。しかし、それによって把持部が内視鏡装着部から離れることはありません。

1. スライダーを引き、把持部を閉じます（図8参照）。

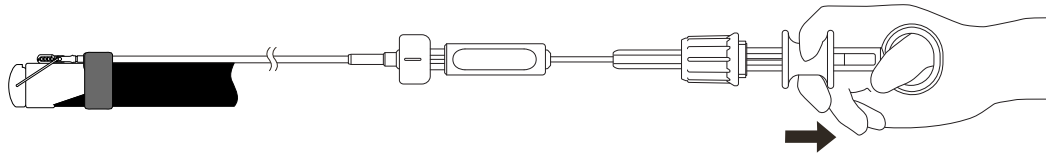


図8

2. 進退ロック部に対してマーカールが完全に見えるまでハンドル部を引き、把持部およびリンクが確実に内視鏡装着部に沿うことを目視で確認します（図9参照）。

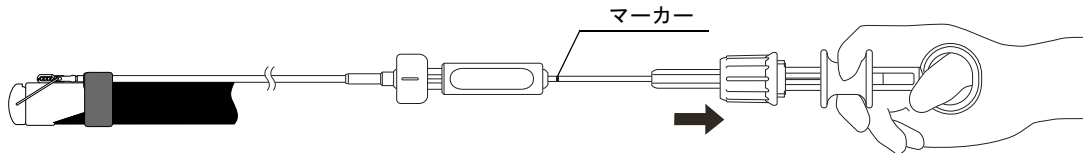


図9

3. 内視鏡挿入部および本製品の先端部外面に潤滑剤を塗布します。
4. オーバーチューブを使用する場合は、オーバーチューブの挿入口にも潤滑剤を塗布します。
5. 把持部が開かないように、スライダーの保持もしくは開閉ロックによるスライダーのロックを行います。
6. 把持部が進退しないように進退ロック部に対して、ハンドル部を引いた状態で保持もしくは、マーカールが見える位置でロックし、体腔内に挿入します。

組織の把持、挙上

警告

- ・ 把持部を進退する際は、把持部を閉じてください。把持部を閉じないで進退操作を行うと、穿孔、出血、粘膜損傷などにつながるおそれがあります。
- ・ 内視鏡の視野内に把持部先端が確認できていない状態で、把持部の開閉を行わないでください。また内視鏡画像で体腔内の状態を確認せずに、把持部の進退を行わないでください。確認せずに操作し続けると、穿孔、大出血、粘膜損傷などにつながるおそれがあります。
- ・ 把持部を突き出した状態での内視鏡の急激な操作は行わないでください。急激な操作をすると、穿孔、出血、粘膜損傷につながるおそれがあります。
- ・ 組織を把持する際は、組織にキャップおよび把持部を強く押し付けしないでください。穿孔、出血、粘膜損傷などにつながるおそれがあります。
- ・ 組織を把持する際は、十分な量の組織を把持してください。把持する組織量が少ないと、粘膜の損傷や大出血につながるおそれがあります。
- ・ 組織を把持した状態で、無理な内視鏡操作を行わないでください。無理に操作すると、穿孔、大出血、粘膜損傷などにつながるおそれがあります。
- ・ 把持した組織を挙上する際は、急激な内視鏡操作、過度な挙上、急激な把持部の進退を行わないでください。また内視鏡操作を行う際は、内視鏡画像で組織の状態を確認してください。無理に操作をし続けると、穿孔、大出血、粘膜損傷などにつながるおそれや、機器の破損につながるおそれがあります。
- ・ 組織を把持、挙上した状態で、急激な内視鏡操作を行わないでください。急激な内視鏡操作をすると、穿孔、大出血、粘膜損傷などにつながるおそれがあります。
- ・ 処置中に把持した組織を離さないために、スライダーを常に引いた状態で保持するか、開閉ロックを使用してください。保持もしくはロックをしていないと把持部が開き、穿孔、出血、粘膜損傷などにつながるおそれがあります。
- ・ 組織の挙上中に進退ロック部から手を離す場合は、進退ロックを行ってください。進退ロックを行わないと、把持部が動き、穿孔、出血、粘膜損傷などにつながるおそれがあります。
- ・ 組織の挙上後は内視鏡視野で処置対象を確認し、処置を行ってください。確認せずに処置すると、穿孔、大出血、粘膜損傷などにつながるおそれがあります。
- ・ 高周波処置具との併用の際は、通電時に高周波処置具が把持部、リンク等の金属部分、キャップに触れないことを内視鏡画像にて確認したうえで通電してください。確認せず通電すると、穿孔、出血、粘膜損傷、組織の熱傷などにつながるおそれや、本製品の破損につながるおそれがあります。
- ・ 使用中にチューブシースと進退ロック部の接続がはずれた場合は、内視鏡湾曲部をまっすぐにし、チューブシースを保持して把持部を内視鏡画像に確認できる状態まで進め内視鏡および本製品を引き抜いてください。無理に引き抜くと、穿孔、大出血、粘膜損傷などにつながるおそれがあります。
- ・ 使用時の内視鏡操作における異常が見つかった場合は、内視鏡を一度引き抜き（「10.3 本製品の使用方法 体腔内からの引き抜き」参照）、本製品の各部や内視鏡の外観および湾曲動作に異常がないかを確認してください。
- ・ 組織を把持していない状態で、把持部を内視鏡視野外に移動させる際は、把持部を閉じた状態に維持したうえで進退ロック部に対してハンドル部を引いてください。マーカールが完全に見えるまでハンドル部を引くことで、把持部およびリンクが内視鏡装着部に沿った状態になります。マーカールが完全に見えるまで引かないと、把持部が内視鏡装着部から浮いた状態となり、周辺の組織の損傷や出血につながるおそれがあります。

注意

把持した組織を挙上する際は、マーカの位置を確認し、必要以上に操作部の引き込みを行わないでください。マーカが見える状態でさらに大きく引き込むと、本製品の破損につながるおそれがあります。

参考

進退ロックが不十分な場合は進退ロックを把持し、もう片方の手でグリップを回転させることで、確実にロックができます。

1. 体腔内への挿入時に進退ロックおよび開閉ロックを行った場合は、各ロックを解除します。
2. スライダーを引き、把持部を閉じた状態で、進退ロック部に対してハンドル部を押し込み、内視鏡画像内で把持部および把持部の向きを確認しながら前進させます（図9参照）。

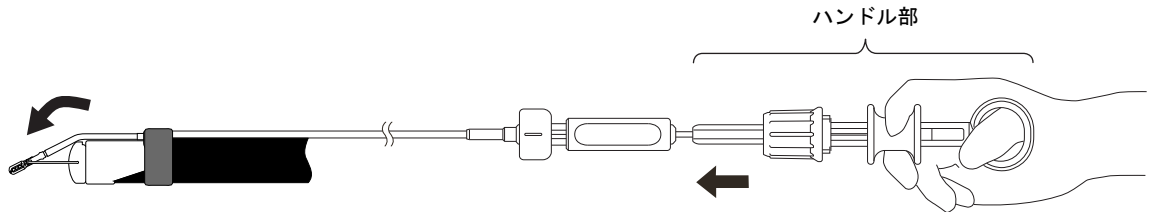


図10

3. スライダーを押し、把持部を開きます（図11参照）。

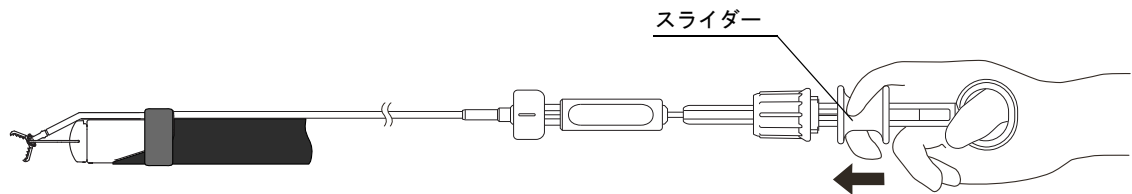


図11

4. スライダーを引き、目的の組織を把持します（図12参照）。
5. スライダーから手を離す場合は、スライダーを引いた状態で開閉ロックをスライダーに突き当て、LOCK シールの矢印の向きに回転させ把持部の開閉を固定します（図12参照）。

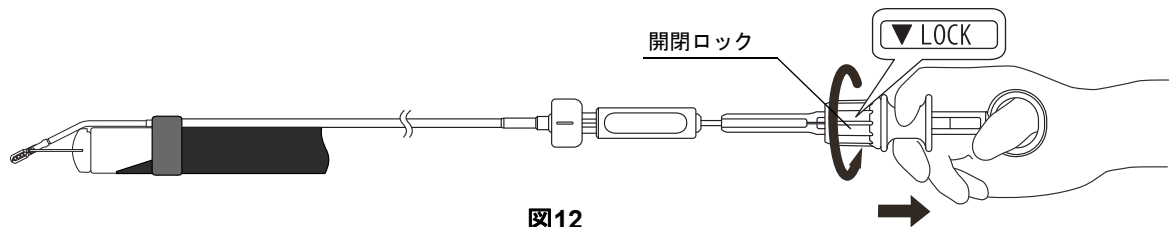


図12

6. 保持した進退ロック部に対してハンドル部を任意の位置まで手元側に引き、目的の組織を挙上します（図13参照）。

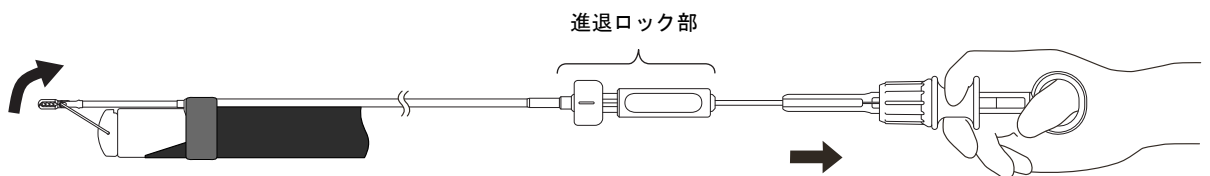


図13

7. 進退ロック部から手を離す場合は、グリップに対して進退ロックをLOCK シールの矢印の向きに回転させ、把持部の進退位置を任意の位置で固定します（図14参照）。

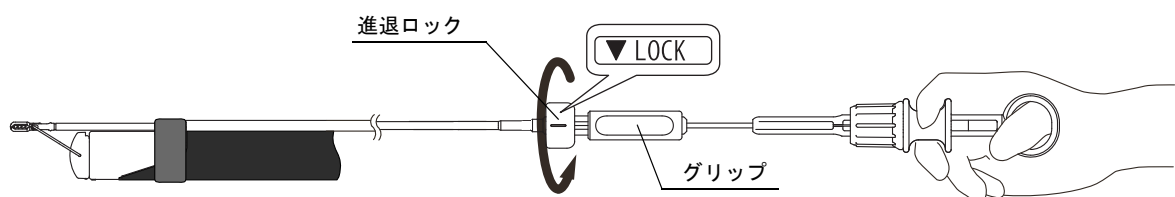


図14

8. 必要に応じて、内視鏡的処置を行います。

体腔内からの引き抜き

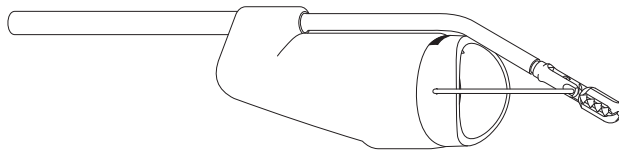
警告

- 引き抜き中は、把持部の進退、開閉を行わないでください。引き抜き中に把持部を操作すると、穿孔、出血、粘膜損傷などにつながるおそれがあります。
- 体腔内から内視鏡を引き抜く際は、把持部を閉じ、内視鏡画像で把持部を確認しながら、ゆっくり引き抜いてください。また、引っ掛かりを感じたときは、無理に引き抜かないでください。無理に引き抜こうとすると、穿孔、出血、粘膜損傷などにつながるおそれがあります。

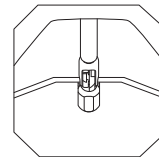
注意

本製品を内視鏡に装着した状態で、内視鏡の吸引による組織回収を行わないでください。本製品を装着した状態で吸引による組織回収を行うと、キャップ内に入り込んだ組織を取り出す際に、キャップ内側のリンクに組織が引っ掛かり、回収した組織を損傷するおそれがあります。

- 組織を回収しない場合は、把持部を開き、把持している組織をはずします。
- 各ロックを解除し、スライダーを引き、把持部を閉じます。把持部が開かないように、スライダーを引いた状態で保持または開閉ロックによるロックをします。
- 進退ロック部に対してハンドル部を進退させ、内視鏡画像内に把持部全体が見えるようにします（図15参照）。



引き抜き時の把持部位置



引き抜き時の内視鏡画像

図15

- 把持部が進退しないように進退ロック部を保持またはロックし、内視鏡画像で把持部を確認しながら体腔内からゆっくり引き抜きます。なお、組織を回収する場合には組織を把持した状態で、本製品と内視鏡を引き抜きます。

取りはずし

警告

- 本製品を内視鏡先端から取りはずす際は、把持部およびリンクを把持せず、キャップの側面を把持してください。把持部およびリンクを把持すると、術者がけがをするおそれがあります。
- 本製品を内視鏡から取りはずす際は、固定している医療用テープをはずしてから行ってください。医療用テープをはずさないで取りはずすと、内視鏡の破損につながるおそれがあります。
- 内視鏡先端部から本製品を勢いよく取りはずさないでください。本製品に付着した患者の血液や粘液などが飛散し、感染などにつながるおそれがあります。

参考

抵抗が大きくて取りはずしが困難な場合は、洗浄液中で本製品の内視鏡装着部を数回つまんで、内視鏡先端部と内視鏡装着部の間に洗浄液を浸透させるようにすると、取りはずしやすくなります。

- 本製品を固定している医療用テープをはずします。
- 本製品を内視鏡先端部からゆっくりと取りはずします。

11 廃棄

警告

- 使用後は、施設や各地方の行政もしくは地方自治による指針に従って適切に廃棄すること。適切な方法で廃棄しないと、感染につながるおそれがあります。
- 本製品は再使用しないでください。再使用すると、感染、組織の炎症などにつながるおそれがあり、また機能の確保ができません。

本製品の使用が終了したら、本製品を適切な方法で廃棄します。

オリンパス メディカル システムズ株式会社



Olympus Customer Information Center Endoscope

内視鏡お客様相談センター

0120-41-7149